

壓力性尿失禁 (SUI) — 男性

病人須知 · 前列腺手術後漏尿 — 用力或活動時出現

WARWIKI

男性壓力性尿失禁 (SUI) 係指當膀胱突然受到壓力時——例如咳嗽、企起身、舉重物或做運動——會漏尿。男性SUI幾乎都係因為前列腺手術或放射治療後，控尿肌肉（括約肌）變弱所致。症狀通常喺頭一年會改善；如果有改善，都有非常有效嘅治療方法。

關於呢個病

前列腺切除後，主要嘅**尿道括約肌**（控制排尿嘅閥門）要獨力工作，而佢可能已經變弱。結果係用力時漏尿——由需要墊片嘅幾滴，到較多嘅漏尿。呢個同**急迫性漏尿**（突然有強烈尿意）唔同，治療方法亦唔同；有啲男士兩種情況都有。

成因

- **根治性前列腺切除術**（因癌症切除前列腺）—— 最常見原因
- 其他前列腺手術或**盆腔放射治療**
- 較少見：神經或膀胱問題

漏尿通常**初期最嚴重**，隨着傷口愈合及盆底肌力恢復，會喺數週至數月內逐漸改善。

詞彙解釋

壓力性尿失禁

因壓力——咳嗽、企起身、舉重物——而漏尿。

括約肌

控制尿液嘅肌肉閥門，等你決定排尿先開。

前列腺切除術

切除前列腺嘅手術，係男性SUI嘅常見原因。

盆底

訓練呢組肌肉可幫助控尿。

墊片測試

每日計算用咗幾塊墊片，用嚟評估漏尿量。

男性吊帶 (sling)

放喺尿道下方嘅支撐物，用於輕中度漏尿。

ProACT 氣球

放喺尿道旁嘅兩個可調節氣球，喺診所調整；係微創選項。

人工尿道括約肌

植入體內嘅裝置（由你控制嘅袖套），用於中重度漏尿。

會唔會自然好返？ 通常會——前列腺手術後嘅漏尿，尤其係做咗盆底運動，一般會喺6-12個月內改善。如果困擾嘅漏尿持續超過約一年，就係考慮吊帶、可調節氣球或人工括約肌嘅時候——呢啲治療效果都好好。

點樣診斷

- 詢問你喺咩情況下漏尿及漏尿量（通常以**每日墊片數**計算）
- **尿液化驗**，及檢查排尿是否完全
- 手術前：用膀胱鏡檢查尿道，有時需要做膀胱功能測試

點樣治療（循序漸進）

- 1 **盆底運動（凱格爾運動）**，理想上喺手術前後開始，同時管理飲水量及體重。
- 2 **頭一年觀察改善情況**，期間按需要使用墊片或護墊。
- 3 **男性吊帶 (sling)** —— 用於持續性輕中度漏尿（無需再做其他手術）。
- 4 **ProACT 可調節氣球** —— 另一輕中度漏尿嘅微創選項；兩個細小氣球喺診所分多次調整（放射治療後不適用）。
- 5 **人工尿道括約肌 (AUS)** —— 係中重度漏尿嘅金標準，亦係放射治療後嘅首選。各有獨立嘅病人資料。

日常照顧

- 持續做盆底運動——呢個係基礎。
- 用墊片或護墊，保持自信地度過康復期。
- 如果夜間漏尿係問題，限制傍晚飲水及咖啡因攝入。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 灼熱感、發燒或**小便有血**（可能係感染）
- **突然無法排尿**
- 漏尿情況惡化而非改善

要記住嘅三件事

1. 男性SUI幾乎都係前列腺手術或放射治療後括約肌變弱所致——通常頭一年會改善。
2. 盆底運動係基礎；如漏尿持續，男性吊帶或人工尿道括約肌效果非常好。
3. 畀康復最多一年時間再考慮手術。如出現發燒、小便有血或無法排尿，請立即致電醫療團隊。